

Infections urinaires (UTI)

WARWIKI

Information pour le patient · Ce qu'est une infection urinaire, comment la traiter et la prévenir

Une infection urinaire (UTI) survient lorsque des bactéries se multiplient dans les voies urinaires. La plupart sont des **cystites** (infections de la vessie) qui provoquent des brûlures, une urgenturie et des mictions fréquentes. Parfois, l'infection atteint un **rein**, ce qui est plus grave. La plupart des infections urinaires guérissent rapidement avec le bon antibiotique, et il existe de bons moyens de prévenir les récurrences.

À propos de cette affection

Une infection de la vessie (**cystite**) provoque généralement :

- **Brûlures ou picotements** en urinant
- **Urgenturie et pollakiurie** — envies fréquentes en petites quantités
- Urines troubles, foncées ou malodorantes ; gêne dans le bas-ventre

Une **infection rénale** (pyélonéphrite) est plus grave et s'accompagne de **fièvre, frissons, douleur lombaire ou dans le flanc, et nausées** — elle nécessite une prise en charge rapide.

Causes

Des bactéries (généralement intestinales) pénètrent par l'urètre et se multiplient dans la vessie. Les facteurs de risque incluent les **rapports sexuels**, la **ménopause** (baisse des œstrogènes), une vidange incomplète de la vessie, les sondes urinaires, les calculs et le diabète.

COMPRENDRE LES TERMES

UTI

Une infection à n'importe quel niveau des voies urinaires.

Cystite

Infection de la vessie — le type d'UTI le plus courant.

Pyélonéphrite

Infection rénale — plus grave, souvent avec fièvre.

Culture d'urine

Examen qui cultive les bactéries pour choisir le bon antibiotique.

UTI récurrente

Infections répétées (souvent 2 à 3 ou plus par an).

Œstrogènes vaginaux

Crème ou ovule à faible dose réduisant le risque d'UTI après la ménopause.

Bactériurie asymptomatique

Bactéries dans les urines sans symptômes — habituellement non traitée.

AI-JE TOUJOURS BESOIN D'ANTIBIOTIQUES ? Si vous avez des symptômes, une UTI est traitée par antibiotiques. En revanche, si un test urinaire détecte des bactéries et que vous vous sentez **bien**, cela n'est généralement **pas** traité — les antibiotiques feraient alors plus de mal que de bien. Exceptions importantes : la grossesse et certains actes urologiques.

Comment on le diagnostique & traite

- Votre équipe confirme une UTI à partir de vos **symptômes** et d'un **test urinaire ou d'une culture**.
- Une cystite est traitée par une **courte cure d'antibiotiques**.
- Une **infection rénale** peut nécessiter un antibiotique plus puissant ou plus long, voire une hospitalisation.
- Terminez la cure complète, même si vous vous sentez mieux avant la fin.

Prévenir les récurrences

- **Buvez suffisamment** et évitez de retenir longtemps vos urines.
- Urinez après les rapports sexuels ; essuyez-vous de l'avant vers l'arrière.
- Après la ménopause, les **œstrogènes vaginaux** peuvent réduire le risque.
- Renseignez-vous sur les options non antibiotiques et, si les infections sont fréquentes, sur une antibiothérapie préventive.

Bon à savoir

- La canneberge et le D-mannose aident certaines personnes ; les preuves sont mitigées — ils sont raisonnables à essayer.
- Des UTI répétées peuvent justifier une recherche de cause (vidange incomplète, calculs).
- Si vous avez une sonde, la présence de bactéries est attendue — le traitement repose sur les symptômes, pas sur le test seul.

Consultez rapidement si vous avez :

- **Fièvre, frissons ou douleur lombaire/dans le flanc** (possible infection rénale)
- Nausées ou vomissements, ou malaise général important
- **Sang dans les urines** visible, ou symptômes ne s'améliorant pas sous antibiotiques
- Vous êtes enceinte et présentez des symptômes d'UTI

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La plupart des UTI sont des cystites (brûlures, urgenturie) et guérissent avec une courte cure d'antibiotiques ; les infections rénales (fièvre, douleur lombaire) sont plus graves.
2. Des bactéries dans les urines **sans symptômes** ne doivent généralement pas être traitées — sauf pendant la grossesse ou avant certains actes.
3. Prévenez les récurrences par une bonne hydratation, la miction après les rapports et (après la ménopause) les œstrogènes vaginaux. Consultez en cas de fièvre, douleur lombaire ou vomissements.